

上海市卫生健康委员会文件

沪卫妇幼〔2022〕6号

关于印发上海市新生儿 先天性心脏病筛查技术方案（2022版）的通知

各区卫生健康委，市妇幼保健中心，有关医疗机构：

为进一步推进本市新生儿先天性心脏病筛查工作，我委组织修订了《上海市新生儿先天性心脏病筛查技术方案（2016版）》，形成了《上海市新生儿先天性心脏病筛查技术方案（2022版）》。现印发给你们，请遵照执行。

特此通知。

上海市卫生健康委员会

2022年2月21日

（此件公开发布）

上海市新生儿先天性心脏病筛查技术方案

(2022 版)

一、先天性心脏病定义

先天性心脏病是胎儿时期心脏及大血管发育异常所导致的先天性畸形，严重影响患儿生命和生活质量。重症先天性心脏病是我国新生儿、婴儿和 5 岁以下儿童死亡的主要原因之一。

二、新生儿先天性心脏病筛查

助产医疗机构医护人员对出生后 6~72 小时以内的新生儿，采用 2 项指标（心脏杂音听诊+经皮血氧饱和度测定）进行筛查，任一指标阳性则为筛查阳性。

（一）筛查对象

上海市助产医疗机构出生的所有新生儿。

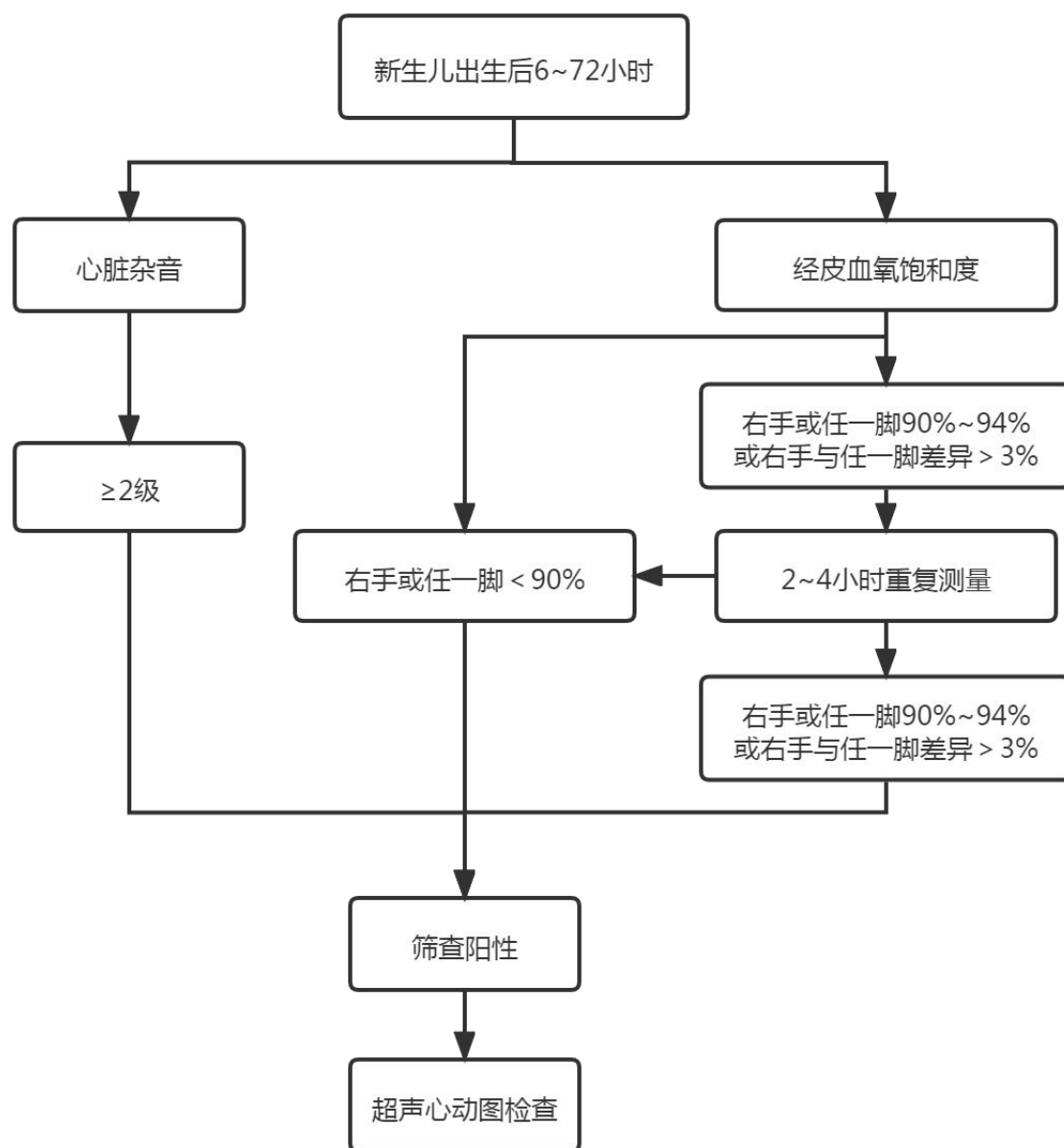
（二）筛查工具

设 备	用 途
新生儿专用听诊器 新生儿专用经皮血氧饱和度测定仪	新生儿先天性心脏病筛查
计算机及相关设备	数据录入、上报及分析

（三）筛查方法

1. 心脏杂音听诊：2 级及以上杂音者为筛查阳性；
2. 经皮血氧饱和度：右手和任一脚测定，任一部位低于 90% 者为筛查阳性；
3. 若右手或任一脚 90~94%，或右手与任一脚差异>3%者，于 2~4 小时内重复测定，若结果相同亦判为筛查阳性。

（四）操作步骤



（五）转诊指标

1. 筛查阳性的新生儿应凭转诊单在1周内转诊到上海市新生儿先天性心脏病诊断网络单位或上海市新生儿先天性心脏病筛查诊治中心进行超声心动图检查明确诊断；
2. 筛查阴性或未筛查的新生儿在出生后7天、42天访视、常规体检时发现有先天性心脏病相关症状或体征的需及时转诊。

三、先天性心脏病诊断

（一）诊断对象

新生儿先天性心脏病筛查阳性的新生儿。

（二）诊断设备

设备	用途
超声心动图诊断仪等设备， 适合新生儿和婴幼儿的探头	评估先天性心脏病的类型、 严重程度等
计算机及相关设备	数据录入、上报及分析

（三）诊断方法

根据超声心动图检查结果做出诊断。疑有其他缺陷或全身疾病者应到相关科室就诊。

（四）超声心动图诊断结果

超声心动图诊断结果分为无先心病、确诊或疑似先心病以及待随访复查确定。其中，待随访复查确定的新生儿在 3 月龄随访，出现以下情况诊断结果改为无先心病，纳入常规健康管理：

1. 新生儿时期动脉导管未闭，3 个月复查时消失；
2. 卵圆孔未闭或房间隔缺损 $\leq 5\text{mm}$ ，3 个月复查时关闭；
3. 生理性肺动脉分支狭窄（流速增快但 $< 2\text{m/s}$ ），解剖无局限性狭窄或发育不良，在 3 个月复查时消失；
4. 肺动脉瓣或主动脉瓣压差 $< 20\text{mmHg}$ ，且 3 个月复查时无进展。

四、先天性心脏病早期干预

1. 确诊或疑似为先天性心脏病的患儿，需进一步评估并制定相应的处理方案。
2. 对先天性心脏病患儿的监护人进行健康教育，如预防肺炎、病情观察和护理等。

五、技术流程

